

Bandelette sous-urétrale (pour l'incontinence d'effort)

WARWIKI

Information pour le patient · Une chirurgie rapide et efficace contre les fuites urinaires d'effort

La bandelette sous-urétrale (mid-urethral sling) est la chirurgie la plus courante pour l'**incontinence urinaire d'effort féminine** — fuites à la toux, au rire, au port de charges ou à l'effort physique. Une fine bandelette de mesh souple est placée sous la partie médiane de l'urètre pour le soutenir et le maintenir fermé lors des hausses de pression. L'intervention est brève, généralement en ambulatoire, très efficace et durable.

À propos de cette intervention

Par une petite incision à l'intérieur du vagin, une bandelette fine est positionnée **sans tension** sous la partie médiane de l'urètre, comme un hamac. Lorsque vous toussiez ou faites un effort, l'urètre s'appuie sur la bandelette et reste fermé. Il n'y a **rien à actionner** par la suite — la bandelette fonctionne seule. Plusieurs voies existent (rétropubienne et transobturatrice) ainsi que des bandelettes « mini » à incision unique ; votre chirurgien choisira la plus adaptée à votre situation.

À propos du mesh

La bandelette sous-urétrale synthétique est l'une des interventions les **plus étudiées** en santé féminine, avec d'excellents résultats à long terme sur la sécurité et l'efficacité. Elle est **différente** du mesh transvaginal utilisé pour le prolapsus, qui a fait l'objet d'avertissements de la FDA. Si vous préférez éviter le mesh synthétique, une bandelette faite avec **votre propre tissu** (bandelette fasciale autologue) est une alternative.

COMPRENDRE LES TERMES

Incontinence d'effort

Fuites lors d'une pression : toux, rire, port de charges.

Bandelette sous-urétrale

Une bandelette de mesh soutenant la partie médiane de l'urètre.

Sans tension

La bandelette repose sous l'urètre sans le comprimer.

Rétropubienne / transobturatrice

Deux voies de passage possibles ; toutes deux sont efficaces.

Bandelette autologue

Bandelette fabriquée avec votre propre tissu, sans mesh synthétique.

Exposition du mesh

Complication rare où une partie du mesh devient visible ; traitable.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'intervention se déroule sous anesthésie (générale ou rachianesthésie), vous ne ressentez rien pendant l'opération, qui dure généralement moins de 30 minutes. La plupart des patients rentrent **chez eux le jour même** avec de légères courbatures et reprennent rapidement une activité légère.

Comment vous préparer

- Respectez les consignes d'**anesthésie** (jeûne, arrêt des anticoagulants selon les instructions).
- Un **examen urinaire** pour écarter toute infection ; parfois un bilan urodynamique au préalable.
- Prévoyez un conducteur ; planifiez un arrêt des activités intenses pendant quelques semaines.

Déroulement

- 1 Vous êtes endormi(e) ou insensibilisé(e) ; des antibiotiques vous sont administrés.
- 2 Une petite incision vaginale est réalisée et la bandelette est placée sans tension sous la partie médiane de l'urètre.
- 3 Les petits points de sortie (au-dessus du pubis ou à l'aîne) se referment seuls ; l'incision vaginale est suturée.
- 4 Vous urinez avant de rentrer chez vous pour confirmer une bonne vidange.

Après l'intervention

- De légères douleurs et quelques saignements mineurs sont normaux.
- **Évitez les efforts lourds, les poussées et les rapports sexuels pendant environ 6 semaines.**
- Parfois une sonde est nécessaire brièvement si la vidange est lente au début.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- L'impossibilité d'**uriner** ou la sensation de ne pas vider complètement
- De la fièvre ou des saignements abondants
- Des douleurs qui s'aggravent, ou plus tard une douleur lors des rapports ou des pertes vaginales (possible problème de mesh)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La bandelette sous-urétrale soutient l'urètre pour stopper les fuites d'effort — intervention brève, ambulatoire, très efficace, sans rien à actionner par la suite.
2. Son mesh est bien étudié et différent du mesh de prolapsus retiré du marché ; une bandelette en tissu autologue est possible si vous le préférez.
3. Évitez les efforts lourds et les rapports ~6 semaines. Appelez si vous ne pouvez pas uriner, avez de la fièvre ou présentez ultérieurement des douleurs ou des pertes.